

Compte Rendu Systématique de 1er entretien

Instructions

Tout patient vu pour la première fois doit bénéficier d'un CR écrit qui constitue un **résumé informatif** du problème clinique posé, et discute synthétiquement la **conduite à tenir**.

Ce compte-rendu est **rédigé par un médecin** qui pour cela s'appuie sur autant de **consultations** que nécessaire, mais aussi sur celles des autres professionnels qui ont participé au bilan initial.

Pour les patients déjà connu est pris en charge, il existe un Compte Rendu Systématisé de suivi tous les 6 mois.

Les CRS se font souvent après plusieurs consultations, et impliquent souvent plusieurs professionnels. Cependant, l'objectif est des les compléter en 2 ou 3 entretiens, sur une à deux semaines. Une fois validé par un senior, ils sont insérés dans le dossier informatisé du patient.

Consignes rédactionnelles :

- le CRS doit être concis et lisible
- évitez les abréviations
- pour les événements toujours noter la date ET l'âge du patient

Nom de l'interne

Date de la demande

C'est la date de la demande de consultation, elle est notée sur la fiche de demande de rendez-vous rempli par le secrétariat.

Contexte

détail

Cela peut-être un premier rendez-vous en consultation, ou un premier entretien à l'occasion d'une hospitalisation. Reprendre les informations disponibles sur la fiche et le

courrier d'accompagnement éventuel. C'est le contexte au moment de la demande. A compléter par ce que le patient rapporte. Explorer par quelles modalités le patient a demandé rendez-vous. Est-ce par hasard ou est-il adressé spécifiquement ? Pour qui ? S'il y a un changement de contexte entre la date de la demande et la date de la première consultation, l'indiquer.

Informations diverses

Date du premier RDV

C'est la date du premier rendez-vous effectif avec le médecin qui va rédiger le CRS. Si ce premier rendez-vous a été précédé de rendez-vous manqués, le noter et en donner les raisons.

Date de fin du CRS et Nom du senior ayant validé le CRS

C'est la date à laquelle le CRS est terminé et validé par un sénior, pour les CRS fait par les internes.

Date ASI et MINI

C'est la date de l'ASI liée au premier contact. Habituellement elle est postérieure à la date du premier RDV. S'il n'y a pas eu d'ASI donnez-en les raisons.

Poids – Taille

Echelles psychométriques de l'

ASI et MINI

Indiquez les scores de sévérité de l'ASI et les catégories diagnostiques remplies par le patient sur le MINI. Le MINI a tendance à sur-diagnostiquer les troubles psychiatriques, mais relire le détail des items validés peut permettre de confronter un diagnostic psychiatrique présent sur le MINI et non retrouvé à l'entretien.

Nb d'entretiens et personnes impliquées

détail

C'est le nombre de consultations effectuées avant la rédaction finale du CRS.

Indiquez aussi les autres professionnels qui ont eu des entretiens avec le patient pendant cette phase et combien d'entretiens ont été faits.

Biographie

détail

Présenter de façon synthétique les éléments biographiques pertinents pour la compréhension du cas et la prise en charge. Ne pas rapporter ici des informations qui trouvent leur place dans d'autres rubriques.

L'objectif est de retrouver les événements de vie importants, qui par la suite seront à mettre en lien avec la modification de comportements de consommation ou de l'état psychiatrique.

Questionnez dès ce moment de l'entretien le lien potentiel entre les consommations et l'événement de vie (par exemple, une rupture sentimentale aura-t-elle favorisé l'augmentation de consommations d'alcool ou inversement ?).

Explorez pour chaque patient :

- la situation familiale
- le parcours scolaire et professionnel (à la recherche de ruptures avec le fonctionnement antérieur)
- le statut judiciaire
- la situation économique

ATCD familiaux

détail

Il s'agit des antécédents familiaux somatiques, psychiatriques, addictologiques et autres qui sont d'intérêt pour le diagnostic et la prise en charge.

Typiquement cela peut se représenter par un arbre généalogique commenté.

Histoire personnelle des consommations

détail

Il s'agit de décrire les différentes consommations de substances et leurs modalités (per os, IV, sniff, fumé) ainsi que l'usage de tout objet de gratification pouvant donner lieu à addiction.

Explorez systématiquement toutes les substances (tabac, alcool, cannabis, opiacés, cocaïne, autres stimulants, hallucinogènes, benzodiazépines) et comportements (jeu, travail, sport, sexe, alimentation).

Commencer par l'objet qui motive la démarche actuelle du patient. Si un TCA n'est pas le motif premier de la demande, en rechercher systématiquement l'existence.

Repérez (en précisant la date (année) et l'âge du patient pour chaque point):

- le contexte de la première prise (comment, où, avec qui?). Que s'est-il passé (effet renforçant positif et / ou négatif, intensité) ?
- la période d'usage sans problème et sa durée
- le passage à un usage qui échappe aux souhaits du patient (« à partir de quand avez-vous commencé à consommer plus que vous ne vouliez ? C'était intermittent ou permanent ? ») ou devient dommageable.
- rechercher les critères addictologiques (dommages, perte de contrôle, craving, rechute) et mettre en exergue des mots clés. Le critère de durée (> 1 an) doit lui aussi apparaître.
- pour chaque substance : notez les objectifs / demandes du patient et ses consommations actuelles (qui constitueront la base du monitoring de l'efficacité de la prise en charge).
- S'il existe de façon contemporaine un événement de vie important, une modification des consommations ou de l'état psychiatrique, questionnez le patient sur la chronologie (quel est le facteur qui précède l'autre) et le lien causal potentiel.
- Le diagnostic d'addiction est difficile à porter si l'apparition de consommations / comportements dommageables est chaque fois contemporaine / secondaire à l'état psychiatrique ou d'événements de vie. Recherchez les périodes durant lesquelles l'éventuel trouble psychiatrique est en rémission / les conditions de vie favorable pour explorer la persistance des dommages dus aux consommations / comportements.
- Toujours explorer les périodes durant lesquelles le patient ne peut ou ne devrait pas consommer (ex : grossesse / allaitement pour les femmes, hospitalisations, transports aérien ou ferroviaire de longue durée ...) et rechercher alors des critères en faveur d'une addiction (craving, compensation par d'autres substances ou comportements, ou mise en place de stratégies d'évitement efficaces ou pas).

Antécédents de thérapeutiques addictologiques

Il s'agit des prises en charge antérieures, qu'elles soient spécialisées ou non. Notez le plus précisément possibles les intervenants et les moyens de les joindre (téléphone, adresse). Détailler les thérapeutiques utilisées (type, objectifs, dosages, durée, résultats).

Récupérez les compte rendus des prises en charge antérieures.

Explorer l'impact de ces prises en charge sur les consommations / comportements / état psychiatrique du patient.

Discussion du diagnostic addictologique

détail

En fonction des éléments rapportés, explorer s'il est possible de déterminer un diagnostic d'addiction. Utiliser et lister les critères du DSM 5 ou de la CIM 10._

Déterminer la date (et âge) d'apparition des critères d'addiction et le nombre d'années d'usage simple ayant précédé.

Rapportez clairement les substances pour lesquelles ni les critères d'abus ni ceux de dépendance ne sont retenus.

N'oubliez pas que la synthèse ne sera possible qu'après le bilan psychiatrique et médical qui suivent.

Histoire médicale psychiatrique

détail

Décrivez les éléments sémiologiques repérables._

Explorez toutes les catégories diagnostiques psychiatriques (et rapportez la présence ou absence d'antécédents).

Rapportez les antécédents de prise en charge, les traitements mis en place, leur efficacité._

Discussion diagnostic psychiatrique autres qu'addictologique

détail

En fonction des éléments rapportés, explorer s'il est **possible** de déterminer un **diagnostic psychiatrique** dans le cadre nosographique du **DSM 5** ou de la **CIM 10**.

Rapporter clairement s'il n'y a pas de diagnostic retenu.

Éventuellement, si approprié, rapporter un diagnostic d'une **autre nomenclature** et en expliquer les raisons.

Toute substance (durant la phase d'usage, de descente et de sevrage) et addiction peut mimer l'ensemble des troubles psychiatriques. Il est donc nécessaire de discuter le diagnostic psychiatrique en fonction du diagnostic addictologique : l'absence de phases d'abstinence totale avec prise en charge centrée sur le craving peut empêcher d'affirmer ou infirmer l'existence d'une comorbidité psychiatrique.

Histoire médicale autre qu'addictologique ou psychiatrique

détail

Il s'agit des événements médicaux et des diagnostics autres que psychiatriques et addictologiques. Indiquez ici les résultats des sérologies virales. Si inconnu l'indiquer explicitement. Inclure les événements chirurgicaux.

attention

PORTEZ UNE ATTENTION AUX COMPLICATIONS TOXICOLOGIQUES POSSIBLES DE L'ADDICTION

Evaluation somatique

Dates dernières sérologies :

VIH, VHB, VHC

Gestité et parité :

G?P?

Autre Contraception

Evaluation du risque cardio vasculaire :

- FDR cardio-vasculaires : HTA, Tabac, insuffisance cardiaque...
- médicaments allongeant le QT : Isrs, méthadone, neuroleptique
- analyse du dernier ECG réalisé : durée du QT, trouble du rythme...
- nécessité de réaliser un nouvel ECG : Oui/ Non

[!info] Evaluation du risque d'encéphalopathie de Wernicke :

Analyse Nutritionnelle :

- apports alimentaires nutritionnels jugés pauvres : oui/non
- comorbidités favorisant la dénutrition : insuffisance cardiaque, insuffisance rénale, chirurgie bariatrique, cancer, maladie psychiatrique
- pathologie aiguë favorisant la dénutrition : vomissements, syndrome infectieux
- perte de poids : nombre de Kg/durée

Analyse neurologique :

- syndrome cérébelleux : oui/non
- paralysie oculo-motrice : oui/non
- confusion : oui/non
- trouble cognitifs : oui/non.
 - Si oui, score MMS, 5 mots de DUBOIS
- autre signe neurologique évocateur

Insertion sociale

Rapporter le statut vis-à-vis des revenus et du logement. Indiquez les éléments de l'insertion sociale vis-à-vis de la scolarité et d'une profession. Rapporter la qualité du réseau de contact sociaux et sa stabilité, ou ses dysfonctions. Explorer comment l'insertion sociale va être compatible ou pas avec l'éventuelle prise en charge. En cas d'absence de problèmes dans ce domaine, l'indiquer explicitement. Si besoin solliciter une AS pour un bilan plus approfondi.

Synthèse

Synthétiser l'ensemble des problèmes présentés par le patient, dans une perspective de diagnostic et en vu d'une éventuelle prise en charge. S'il existe plusieurs diagnostics tenter une hiérarchisation en perspective de la conduite à tenir. C'est ici qu'il faut discuter les intrications addictions et psychiatrie et complications médicales.

Proposition de Conduite à tenir

Indiquez de façon concrète une ou plusieurs conduites à tenir possibles, à court et moyen terme.

La CAT doit prendre en compte l'ensemble des problèmes du patient décrit dans la synthèse. Ne pas oublier en particulier la CAT vis à vis d'un bilan complémentaire (bilan biologique nutritionnel, IRM cérébrale injectée (en l'absence d'allergie), traitement curatif par vitaminothérapie B1).

Si la conduite à tenir pose problème et nécessite une discussion et des avis consultatifs autres, l'indiquer.

Si la CAT ne pose pas de problème, l'indiquer aussi clairement.

 important

En fonction des souhaits du patient et de ses possibilités, indiquer un projet de CAT pour les 6 mois à venir. Inclure les critères d'évaluation *a priori* qui seront examinés dans 6 mois.